

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

INTRODUCCIÓN

Se hace necesario para el talento Humano de Enfermería de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, contar con un protocolo que permita estandarizar el proceso de atención de enfermería, favorecer la adherencia del personal a prácticas seguras, que lleven a la institución a la disminución de complicaciones producto de eventos adversos prevenibles.

La mayoría de los usuarios que ingresan a estancias hospitalarias requieren para su tratamiento, la inserción de catéteres venosos periféricos, que aseguren la vía de administración endovenosa de medicamentos y fluidoterapias; este procedimiento, se convierte en una actividad de gran relevancia en la práctica diaria de Enfermería en los servicios, sin embargo, los pacientes están expuestos al riesgo de presentar complicaciones derivadas de este procedimiento invasivo. Las flebitis en cada una de sus clasificaciones (mecánicas, químicas y bacterianas), se convierte de entrada en la complicación más frecuente de eventos adversos relacionada con el uso de dispositivos médicos.

Es por tal razón que esperamos el siguiente protocolo permita al talento humano la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en especial al personal de Enfermería, avanzar hacia cambios de comportamiento y conducta, desarrollar el ejercicio de las profesión con prácticas adecuadas y seguras, con corazón para servir.

1. POBLACIÓN OBJETO

Usuarios hospitalizados de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, con requerimiento de tratamiento intravenoso.

2. USUARIOS DEL PROTOCOLO

Aplica a todo el talento Humano asistencial de la institución encargado del cuidado integral de los Pacientes.

3. OBJETIVOS

GENERAL

Elaborar un plan de manejo para paciente adulto y pediátrico, basado en la evidencia científica disponible para la inserción, cuidado y mantenimiento de los accesos venosos periféricos con el fin de prevenir complicaciones, encaminado a garantizar la seguridad del paciente.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

ESPECÍFICOS

- Estandarizar el proceso de inserción, mantenimiento y retiro de los catéteres venosos periféricos.
- Describir el procedimiento de venopunción con el propósito de minimizar el riesgo de eventos adversos en la atención de enfermería.
- Garantizar la adherencia al protocolo institucional y prevenir complicaciones.
- Ofrecer atención de calidad con humanización en los servicios de salud.

4. MÉTODO USADO PARA COLECTAR/SELECCIONAR EVIDENCIA

Producción intelectual y elaboración del protocolo con talento humano de enfermería de la institución con experiencia en clínica en manejo de accesos venosos periféricos y entrenamiento específico en esta área.

El protocolo se elaboró tomando múltiples referencias bibliográficas del que hacer de Enfermería en el manejo de accesos vasculares, búsqueda en bases de datos electrónicas, revisión de literatura científica en especial del INS.

El protocolo contará con una vigencia acorde a la evidencia y actualización clínica disponible o 5 años, si no amerita cambios.

Tabla 1. Sistema de Clasificación GRADE

Tipos de Fuentes	Fuentes	
Alta	Confianza alta: Es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza en el efecto estimado	A
Moderada	Confianza Moderada: Es probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza del efecto estimado y pueden cambiar los resultados.	B
Baja	Confianza en la estimación del efecto limitada: Es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza del efecto estimado y probablemente cambien los resultados.	C
Muy Baja	Confianza muy poca en la estimación del efecto: Cualquier estimación del efecto es incierta.	D

Fuerza de las Recomendaciones		
Fuerte a favor	La mayoría de las personas bien informadas estarían de acuerdo con la acción recomendada, sólo una pequeña proporción no lo estaría.	1
Fuerte en contra	Las recomendaciones pueden ser aceptadas como una política de salud en la mayoría de los casos	1
Débil a favor	La mayoría de las personas bien informadas estarían de acuerdo con la acción recomendada pero un número importante no.	2

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Débil contra	en	<i>La decisión como política de salud amerita un debate importante y una discusión con todos los grupos de interés.</i>	2
-------------------------	-----------	---	----------

5. DESARROLLO DEL PROTOCOLO

5.1 DEFINICIONES

- **VÍA VENOSA PERIFÉRICA:** Se entiende por **vía o acceso venoso periférico** al abordaje de una vena superficial de localización extra-aponeurótica, generalmente en las extremidades superiores.
- **VENOPUNCIÓN:** Es el procedimiento que consiste en atravesar la barrera de protección exterior (piel) por vía extra cutánea con un catéter de poliuretano de vialón, penetrando en un área totalmente aséptica (sistema circulatorio). Con el fin de mantener una vía venosa permeable, administrar sustancias terapéuticas requeridas por el paciente.
- **TÉCNICA DE REJILLA:** Es una fricción con movimientos hacia adelante y hacia atrás sobre el sitio de inserción o incisión que permite que la solución llegue mejor a las bacterias y las destruya, se debe garantizar que el sitio de inserción reciba el suficiente antiséptico y así la solución pueda penetrar las 5 primeras capas de células de la epidermis y finaliza del centro a la periferia.
- **TÉCNICA PULSÁTIL:** Lavado pulsante que genera turbulencia dentro del catéter para garantizar una adecuada limpieza de las paredes y poder eliminar el depósito de elementos como fibrina o hematíes.

5.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

5.2.1. INDICACIONES DE INSERCIÓN DEL CATÉTER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO

- Hidratación
- Administración de medicamentos
- Administración de nutrición parenteral.
- Administración de medios de contraste.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- Administración de transfusiones de hemocomponentes.

5.2.2. SELECCIÓN ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO Y DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO (DAVP) CORTO.



Gráfica 1. Venas indicadas para la inserción del catéter intravenoso periférico en paciente Adulto

- **Vena Metacarpiana:** Las venas metacarpianas se extienden a lo largo del dorso de la mano y se unen a la vena cefálica a la altura de la muñeca.
- **Vena Basílica:** La más gruesa, asciende por el lado interno del antebrazo y llega a la cara anterior de la extremidad un poco por debajo del codo. En el pliegue del codo recibe la comunicación con la cefálica, se extiende hacia arriba a lo largo del borde interno del antebrazo hasta el codo. Continúa aproximadamente hasta el medio del brazo y se une a la vena braquial. La vena basílica y la vena braquial se unen y continúan como la vena axilar.
- **Vena Cefálica:** Comienza a nivel de la muñeca y pasa a la cara anterior, asciende en el lado extremo hasta llegar finalmente al surco delto pectoral, entre los deltoides y el pectoral mayor, desemboca en la vena axilar. Se extiende a lo largo del bíceps hasta el hombro, donde se une con la vena axilar justo debajo de la clavícula.
- **Vena Braquial:** El término “Braquial” se refiere al brazo, concretamente a la zona comprendida entre el codo y el hombro. Las dos venas braquiales acompañan a la arteria braquial. Cada vena comienza justo por debajo de la articulación del codo y

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

ascienden hasta el tendón del músculo redondo mayor en la axila, drenan en la vena axilar.

- **Vena Axilar:** Es una continuación de la vena basílica de los brazos. Es una vena grande que se extiende a lo largo del tórax hasta la primera costilla, donde se convierte en la vena subclavia. La vena cefálica se une con ésta justo antes de convertirse en la vena subclavia.
- **Vena Cubital:** Es una vena profunda del antebrazo que acompaña a la arteria cubital. Viene de la mano y sube por el borde del carpo (muñeca), por el antebrazo y hasta la flexura del codo, donde desemboca en la vena braquial.

Recomendaciones de elección del acceso venoso periférico en el adulto:

Para la selección del acceso venoso periférico, se debe tener en cuenta:

- La osmolaridad del medicamento o infusión: < 500 mOsm/L
- PH del medicamento o infusión: entre 5 – 9

La terapia parenteral periférica idealmente debe ser isotónica y de pH fisiológico. (Ver tabla de dilución y estabilidad de medicamentos y la tabla de consolidado de estabilidad de medicamentos multidosis. Ruta: Manuales HUN / servicio farmacéutico / farmacia / Abastecimiento / formatos).

- Tipo de medicación: Medicamentos no irritantes, no vesicantes, no vasoactivos. (Ver tabla de dilución y estabilidad de medicamentos y la tabla de consolidado de estabilidad de medicamentos multidosis. Ruta: Manuales HUN / servicio farmacéutico / farmacia / Abastecimiento / formatos).

- Características vasculares.

SELECCIÓN DE ACCESO VENOSO	
VENAS PARA USAR	VENAS PARA EVITAR
Miembros superiores	Miembros inferiores
Partes distales por encima de las canalizaciones anteriores y en zona del dorso	Venas pequeñas y muy superficiales
Antebrazo, mejor que la mano	Evitar zonas de flexión de la articulación

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Buen diámetro, palpables y con buen llenado capilar	Venas utilizadas previamente
Dentro de lo posible, elegir el brazo no dominante	Piel deteriorada. Miembro con afectación clínica o zona infectada. Extremidad con Fístula arteriovenosa FAV, Hemiparesia, vaciamiento ganglionar, etc)

- La capacidad y los recursos disponibles para instalar y cuidar el DAVP.
- Edad del paciente, sus comorbilidades.
- Antecedentes de terapia de infusión.
- Preferencia por el tipo y ubicación del DAVP
- Número de terapias de infusión (simple Vs múltiple).
- Duración prevista de la terapia:
 - a. < 6 DÍAS:** Insertar un catéter intravenoso periférico corto (PIVC) cuando todos los elementos anteriores indiquen una terapia periféricamente compatible.
 - b. (7-14 días):** Inserte un catéter de línea media en pacientes adultos hospitalizados cuando todos los elementos anteriores indiquen una terapia periféricamentecompatible.
 - c. (>15 días):** considere la inserción de un dispositivo de acceso vascular central (CVAD).
- Velocidad de flujo por indicación médica y necesidad del paciente

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNEiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

VENA	DIAMETRO APROXIMADO	VELOCIDAD DE FLUJO
Venas Metacarpianas	2-5 mm	10 ml/min
Antebrazo	6 mm	20 ml/min
Vena Basilica	8 mm	90-150 ml/min
Vena Axilar	16 mm	150-350 ml/min
Vena Subclavia	19 mm	350-1500 ml/min
Vena Cava Superior	20 mm	2000 ml/min

Venas indicadas para la inserción del catéter intravenoso periférico en paciente pediátrico:

- **Vena safena interna y externa:** Es una gran vena superficial del miembro inferior, se ubica por delante del maléolo interno, se origina en la vena dorsal del dedo pulgar donde se une al arco dorsal del pie, luego corre anterior al maléolo medial, asciende por la superficie medial de la pierna y luego corre posterior al epicóndilo medial del fémur, continua hacia arriba en el muslo y pasa sobre la superficie medial del muslo.
- **Arco venoso dorsal del pie:** Está formado por las venas dorsal y digital, se une medialmente con la vena dorsal del dedo pulgar del pie para formar la vena safena mayor.
- **Vena yugular externa:** Vena que se ubica en la zona cervical anterior, desciende desde el ángulo de la mandíbula hasta la parte central de la clavícula y desemboca en la vena subclavia.

Para la selección de acceso venoso periférico en niños es importante tener en cuenta el Score DIVA (tabla 1) la cual es una herramienta para identificar accesos venosos dificultosos en pediatría que considera palpabilidad y visibilidad venosa, edad y antecedente de prematuridad. El puntaje va desde 0 a 10 puntos. Valores mayores a 4 se asocian a acceso venoso difícil. Existen factores de riesgo asociados: obesidad,

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

malformaciones osteomusculares, tratamiento con quimioterapia, diabetes mellitus, pacientes en diálisis, edema de extremidades, deshidratación moderada a severa, historia de acceso venoso difícil, ansiedad del paciente y/o padres que refieren que el niño es poco probable que coopere.

Tabla 1. Cálculo del DIVA Score		
Variable	Opciones	Puntos
Vena visible después de torniquete	Visible	0
	No Visible	2
Vena palpable después de torniquete	Palpable	0
	No Palpable	2
Edad	> ó Igual a 3 años	0
	1-2 años	1
	< 1 año	3
Antecedente de prematurez edad gestacional < 38 semanas	No	0
	Si	3

Tabla 1. Score DIVA

Se ha demostrado que valores mayores a 4 suelen requerir varias punciones para el acceso venoso, para lo cual se debe requerir de personal más experimentado y uso de ayuda de ecografía.

En resumen, el flujo de trabajo se puede sintetizar en los algoritmos que se describa a continuación:

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

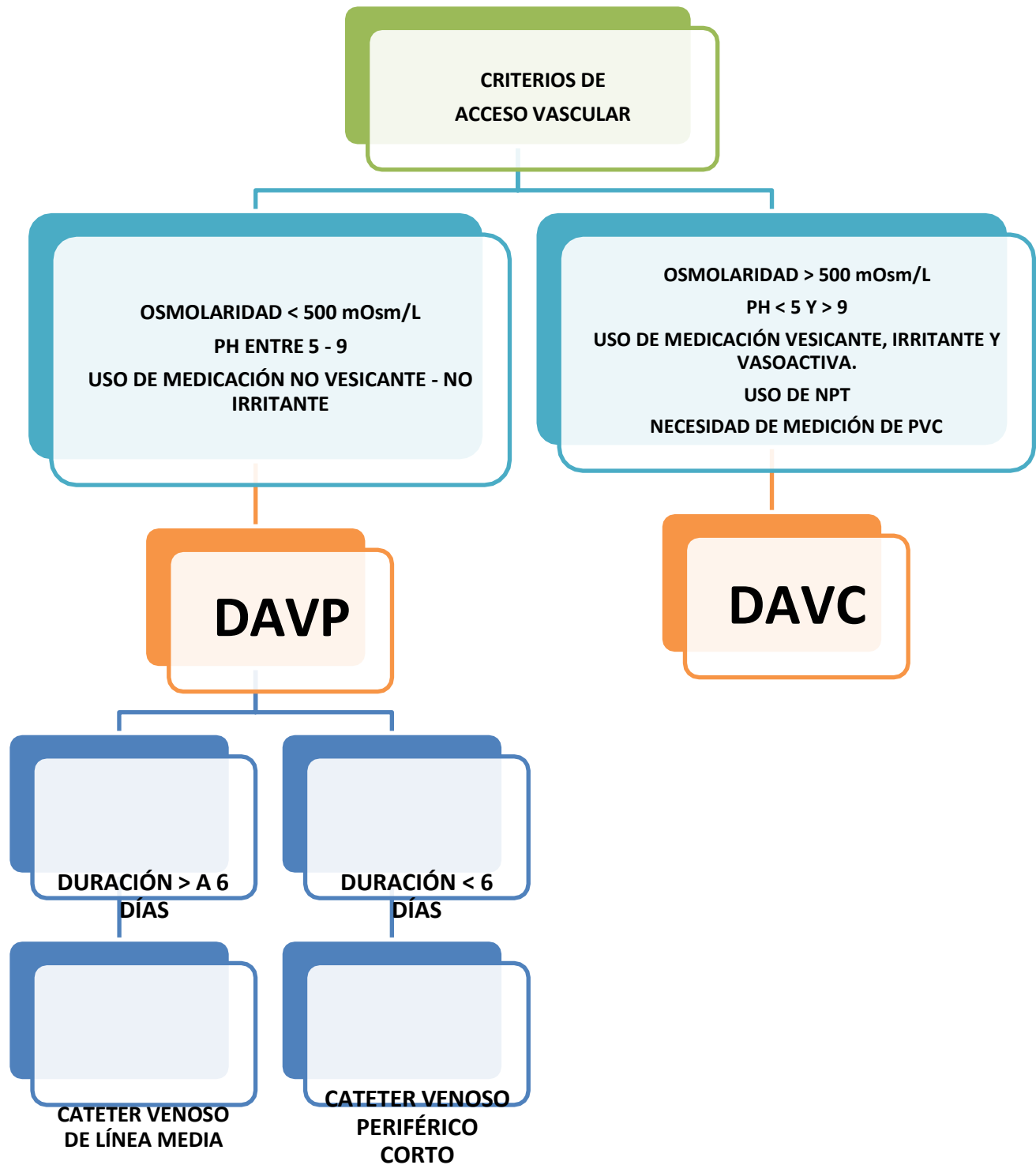
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Algoritmo de selección del Acceso Venoso periférico en Adulto



¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

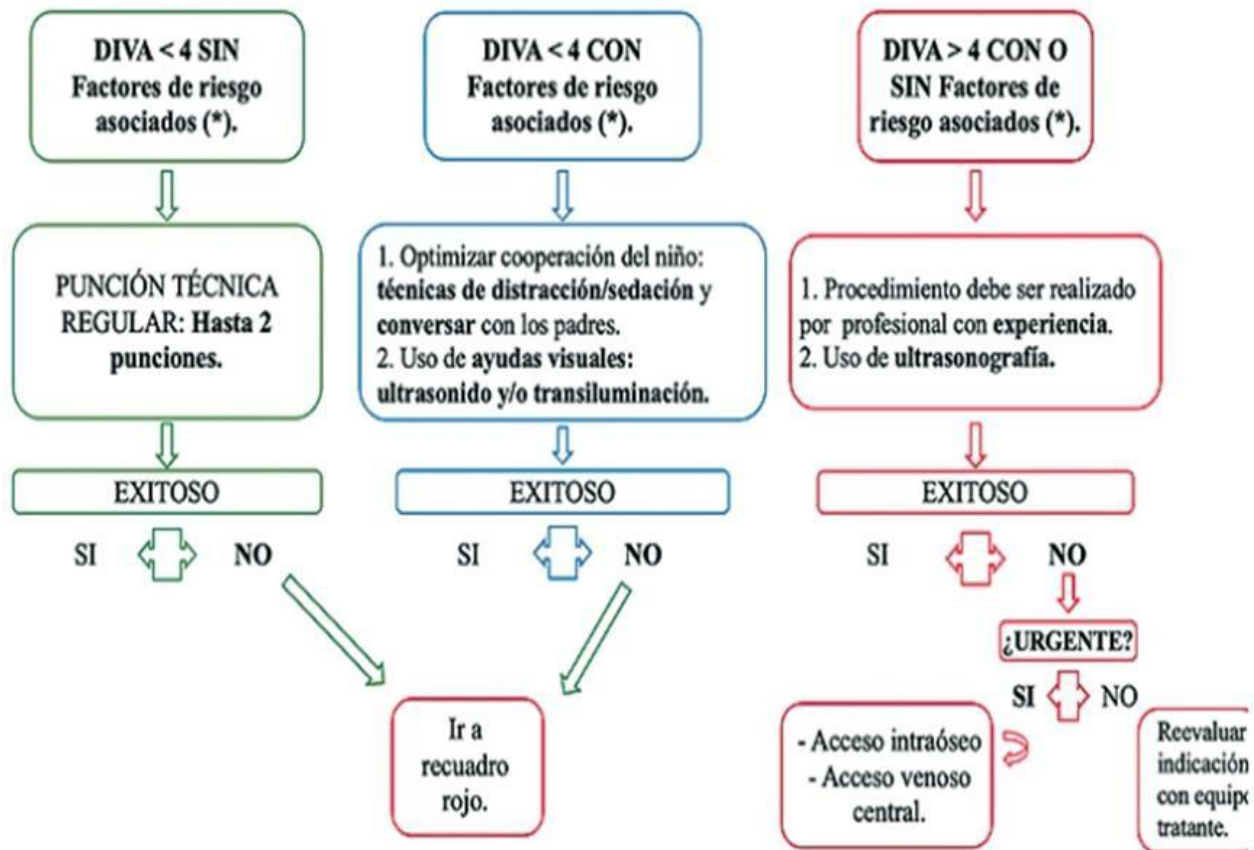
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Algoritmo de selección del Acceso Venoso periférico en Pediatría:



Factores de riesgo (*)	
Obesidad	Edema de extremidades.
Malformaciones osteomusculares.	Deshidratación moderada a grave.
Tratamiento con quimioterapia.	Historia de acceso venoso difícil y/o múltiples punciones.
Diabetes Mellitus.	Ansiedad del paciente y/o padres refieren que el niño es poco probable que coopere.
Pacientes en diálisis.	

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Dispositivo de Acceso vascular periférico (DAVP) o Catéter intravenoso periférico (PIVC)

- Definición:**

Es un catéter de poliuretano de vialón, para ser insertado en un área totalmente aséptica (sistema circulatorio) con el fin de mantener una vía venosa permeable y administrar sustancias terapéuticas requeridas por el usuario.

Las características de estos dispositivos deberán proporcionar una tecnología adecuada favoreciendo la calidad y la seguridad del paciente, entre estas tenemos: Termo flexibilidad, biocompatibilidad, resistencia a acodaduras, bisel atraumático (preferiblemente Penta biselado que proporcione un corte de piel que minimice las lesiones y no presente fugas de sangre luego de insertado el catéter), Radio opaco (que permita la visualización y ubicación del catéter en exámenes diagnósticos radiológicos).

Se recomienda que el PIVC presente un sistema de seguridad, que encapsule la aguja eliminando el contacto del personal que lo está instalando con la aguja contaminada.

Los PIVC se insertan en las venas superficiales ubicadas justo debajo de la piel en el tejido superficial, así como en las venas profundas ubicadas debajo del tejido muscular.

- Clasificación:**

Catéter intravenoso periférico corto (PIVC corto): Generalmente insertado en venas superficiales.

Los dispositivos de acceso vascular periférico corto, presentan diferentes calibres para ser instalados según las necesidades del usuario. Para su selección se debe tener en cuenta el sitio de inserción del catéter, es decir, la ubicación y características de la vena, además la velocidad del flujo de los líquidos o medicamentos indicados, ya que se debe tener en cuenta la adecuada proporción Vena – catéter y este no debe ocupar más del 45% de la vía venosa.

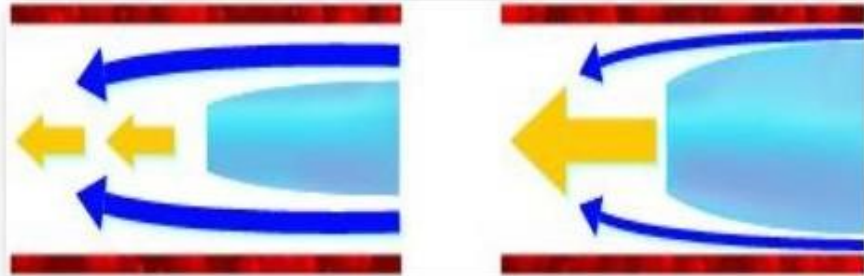
¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42



Adecuada proporción vena-catéter
No debe ocupar mas del 45% del lumen del catéter

Imagen tomada de: Recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. Consenso Latinoamericano, 2020

Journal of Infusion Nursing INS standards of practice 2021(Estandar 53)

En la institución se podrán encontrar los siguientes calibres de los DAVP, identificados por colores estandarizados.

- 14 Gauge (calibre) - Naranja.
- 16 Gauge (calibre) - Gris.
- 18 Gauge (calibre) - Verde oscuro.
- 20 Gauge (calibre) - Rosado.
- 22 Gauge (calibre) - Azul.
- 24 Gauge (calibre) - Amarillo – Insyte autoguard (Pediátrico)
- 24 Gauge (calibre) - Amarillo - Insyte -N autoguard (Neonatal)

Recomendaciones:

- Seleccione el catéter intravenoso periférico (PIVC) de calibre más pequeño que se adapte a la terapia prescrita y las necesidades del paciente. Los catéteres periféricos de calibre mayor al 20 Gauge, son más propensos a causar flebitis (analice el caso de manera individualizada).
- Use un catéter de calibre 22 a 24 para recién nacidos, pacientes pediátricos, adultos mayores y pacientes con opciones venosas limitadas para minimizar el trauma relacionado con la inserción (analice el caso de manera individualizada).
- Garantice un catéter intravenoso periférico (PIVC) corto de gran calibre para pacientes adultos y pediátricos cuando se requiere un reemplazo rápido de líquidos, como en pacientes con traumatismos, maternas con hemorragia, procedimientos quirúrgicos, etc. (analice el caso de manera individualizada).

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- Pacientes adultos llevados a procedimientos quirúrgicos programados ó de urgencia considere un acceso vascular de gran calibre 18 ó 20 (analice el caso de manera individualizada).
- Use un catéter de calibre 20 a 24 según el tamaño de la vena para la transfusión de sangre. Se recomienda un catéter de gran calibre cuando se requiere una transfusión rápida.

Catéter intravenoso periférico largo (PIVC largo):

Insertado en venas periféricas superficiales o profundas ofrece una opción cuando un catéter intravenoso periférico (PIVC) corto no es lo suficientemente largo para canular adecuadamente la vena disponible. Se puede insertar un PIVC largo a través de la técnica tradicional sobre la aguja o con procedimientos más avanzados, como las técnicas Seldinger y acelerada de Seldinger.

Catéter de línea media

Se trata de un catéter diseñado para ser insertado en la fosa antecubital, situándose la punta del catéter en el lecho vascular que se encuentra debajo de la axila. Frente a las limitaciones del catéter corto periférico, la línea media permite un acceso vascular periférico, el cual facilita el acceso a un calibre de vena suficientemente grande, como para evitar las complicaciones relacionadas con una localización muy periférica de la punta del catéter (flebitis, extravasación). Está indicado para fármacos poco irritantes y terapias de duración superior a los 7 días, siendo habitual su permanencia entre 2 y 4 semanas.

5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.3.1. REVISIÓN DE HISTORIA CLÍNICA

El personal de enfermería debe realizar la revisión de la historia clínica, evolución y órdenes médicas, para programar la instalación del catéter intravenoso periférico, según las indicaciones de inserción.

Si es una situación de emergencia, se puede insertar inmediatamente, bajo una orden médica verbal, donde luego se procederá por parte de cada disciplina (médico y personal de enfermería) a realizar los registros en la historia clínica sistematizada y las solicitudes de insumos correspondientes en el área de farmacia.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

5.3.2 EDUCACIÓN AL PACIENTE

El papel del personal de enfermería es muy importante en el desarrollo de actividades educativas que permitan una atención humanizada y de calidad, por lo que se deben tener en cuenta aspectos relevantes en la información suministrada al usuario, familia o cuidador.

Inicialmente se debe reconocer las poblaciones con mayor probabilidad de tener una baja alfabetización en salud: adultos mayores, minorías y aquellos con dominio limitado de alfabetización digital, para crear estrategias de enseñanza que reconozcan que todos los pacientes y cuidadores pueden tener dificultades para comprender la información relacionada con la salud. Dado lo anterior, se debe simplificar la comunicación y seleccionar métodos de educación basados en una evaluación de la edad, el nivel cognitivo y de desarrollo, la alfabetización en salud, el acceso a recursos educativos y tecnología, el estilo de aprendizaje preferido, las influencias culturales y religiosas, etc.

La educación que se le brinda al usuario o cuidador, en el marco de la comunicación asertiva sobre el procedimiento a realizar, debe ser adecuado, confirmando la comprensión de la información suministrada, para minimizar datos erróneos. Evitar la jerga médica, utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Según la valoración del personal de enfermería, si es necesario para mejorar la comprensión del procedimiento, su importancia y sus indicaciones, el uso de información digital y/o tecnología impresa (rotafolio), podrá permitir el aprendizaje y su retroalimentación permanente, obteniendo una adecuada retención de las prácticas de autocuidado del dispositivo de acceso vascular periférico (DAVP).

La información suministrada al paciente, familiar o cuidador sobre el procedimiento de inserción, cuidado y mantenimiento de accesos venosos periféricos, deberá contener: Indicación y necesidad de la inserción del dispositivo, objetivos del procedimiento, ejecución de la inserción, terapia de infusión prescrita y el plan de atención, incluidos, entre otros, la duración esperada de la terapia, los riesgos y los beneficios, efectos adversos, precauciones para prevenir infecciones y otras complicaciones, la técnica aséptica y la higiene de manos, las limitaciones de actividad y la protección del dispositivo mientras se realizan actividades cotidianas.

Además, se deberá validar la adquisición de conocimientos o información suministrada, al paciente, familiar o cuidador y hacer el registro en la Historia clínica de las estrategias ejecutadas. Por todo lo anterior, se ha elaborado una infografía sencilla, para suministrar al usuario, familiar o cuidador la información relevante en el cuidado de estos catéteres.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

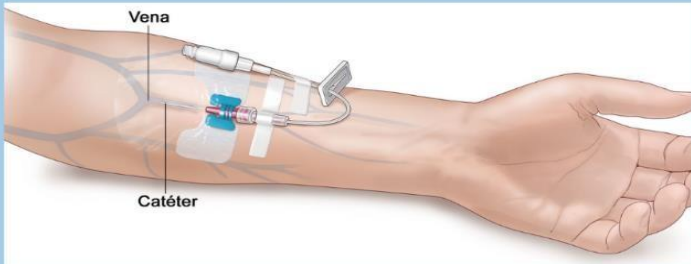
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Anexo 1. Cuidados centrados en el Usuario y su familia en Accesos Vasculares Periféricos.

ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO

CUIDADOS CENTRADO EN EL USUARIO Y SU FAMILIA



DEFINICIÓN

ES EL PROCEDIMIENTO QUE CONSISTE EN ATRAVESAR LA PIEL CON UN CATÉTER, HASTA LLEGAR AL SISTEMA CIRCULATORIO, CON EL FIN DE MANTENER UNA VÍA VENOSA PERMEABLE PARA ADMINISTRAR SUSTANCIAS TERAPÉUTICAS REQUERIDAS POR EL PACIENTE (MEDICAMENTOS, LÍQUIDOS, NUTRICIÓN, TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS, ETC.)

CUIDADOS DEL CATÉTER Y DEL SITIO DE PUNCIÓN

HIGIENE DE MANOS

- ANTES Y DESPUÉS DE TENER CONTACTO CON EL USUARIO
- ANTES Y DESPUÉS DE TENER CONTACTO CON EL ENTORNO DEL PACIENTE (CAMA, MESA, SILLA, ETC.)



INFORMAR AL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN CASO DE:



1. SIGNOS DE ALARMA (en el sitio de punción)
 - DOLOR
 - INFLAMACIÓN
 - ENROJECIMIENTO
 - HEMATOMA
 - HUMEDAD
2. SI EL ADHESIVO QUE FIJA EL CATÉTER, SE ENCUENTRA SUELTO O LEVANTADO,
3. SI PRESENTA SANGRADO EN EL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER.



EVITAR:

- MANIPULAR FRECUENTEMENTE LOS EQUIPOS DE INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS.
- HUMEDECER EL SITIO DE PUNCIÓN DEL CATETER.
- TRACCIONAR - HALAR EL CATETER O LOS EQUIPOS DE INFUSIÓN QUE PUEDAN OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO O RETIRO DE ESTOS DISPOSITIVOS.
- QUE LOS EQUIPOS DE INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOQUEN EL PISO, O PRESENTEN DESCONEXIÓN.

EN TUS MANOS ME SIENTO TRATADO CON
SEGURIDAD Y CALIDEZ




 ¡Corazón para servir!

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

5.3.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO

El equipo de salud debe reconocer que obtener el consentimiento informado es un proceso educativo que involucra al paciente en la toma de decisiones compartida. El proceso comienza con un diálogo entre el usuario o familiar, y el personal de enfermería calificado que realiza el procedimiento.

Garantizar que el proceso de consentimiento informado incluya estos elementos obligatorios:

- El consentimiento es voluntario y está libre de coerción o persuasión.
- El usuario, familiar o acudiente ha recibido la información necesaria para comprender el procedimiento/tratamiento, su propósito, riesgos, beneficios potenciales, procedimientos/tratamientos alternativos, complicaciones comunes y riesgos potencialmente graves o irreversibles

El consentimiento informado debe ser diligenciado previo a la realización del procedimiento, sin embargo, se pueden presentar excepciones basadas en condiciones a los requisitos para el consentimiento informado (p. ej., situaciones de emergencia/que amenazan la vida, incapacidad del paciente sin un sustituto para la toma de decisiones), por lo cual se requiere que cualquier situación presentada, quede consignada en la historia clínica y en el kárdex de enfermería, la firma pendiente, hasta que el acudiente o familiar responsable, pueda culminar el proceso.

5.3.4 PREPARACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CORTO.

Para la instalación del dispositivo de acceso vascular (DAVP), es necesario centralizar todos los dispositivos e insumos en un único lugar.

- Mesa de curaciones, mesa de mayo o cubeta en acero inoxidable; este debe estar previamente limpio y desinfectado con una solución que contenga GLUTARALDEHÍDO + FORMALDEHIDO + CETRIMIDA con una compresa (teniendo en cuenta la técnica de limpieza y desinfección), para la colocación de todos los insumos que se requieren en el procedimiento.
- Elementos de protección personal (mascarilla facial, guantes limpios, monogafas, gorro).

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- Catéter o dispositivo de acceso vascular periférico (DAVP), según las indicaciones y calibre para su selección.
- Toallas, sachet o esponjas de clorhexidina al 2% en base alcohólica al 70%.
- Torniquete adecuado al tamaño del paciente. (No guante). Banda ancha y elástica.
- Apósito transparente estéril (Con tela de refuerzo tejida).
- Llave de 3 vías (si se requiere), y en cada puerto preferiblemente un conector libre de aguja para mantener sistema cerrado o extensión microbore con microclave, extensión bifurcada o trifurcada microbore con microclave.
- Conector libre de aguja transparente, preferiblemente de presión neutra que resista mínimo 100 activaciones y 32Lt hora. En el caso de personal de pediatría: Conector Nano clave.
- Otros insumos o elementos de venopunción según lo requerido por el usuario: Equipo macrogoteo, equipo de bomba de infusión, extensión de anestesia, equipo de transfusión sanguínea, etc. debidamente purgado, sin aire ó burbujas en su trayecto.
- Jeringa precargada de SSN 0.9% con barril de 10cc, 5cc o jeringas x 10 o 5 cc estéril y bolsa de SSN 0.9% estéril.
- Contenedor de elementos cortopunzantes (guardián) y caneca de residuos, según corresponda.
- Consentimiento informado firmado.
- Historia clínica para la verificar la orden médica, y realización de registros respectivos.

5.3.5. LAVADO DE MANOS Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La aplicación de las precauciones estándar, son de obligatorio cumplimiento, como estrategia de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud y prevención de accidentes biológicos y enfermedades laborales. Ver: manuales HUN / epidemiología e infectología / Manuales / Manual de prevención y control de infecciones, Pág. 33.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Lavado de manos

Antes y después de realizar la inserción del catéter intravenoso periférico, por ser un procedimiento que tiene contacto con fluidos corporales, es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, (gluconato de clorhexidina) aplicando los 11 pasos, con una duración de lavado entre 40-60 segundos. Ver: manuales HUN / epidemiología e infectología / Manuales / Manual de prevención y control de infecciones, Pág. 20.

La higiene de las manos es necesaria:

- Antes y después de la palpación del punto de inserción.
- Antes y después de la movilización, manipulación del catéter y cambio de apósitos.
- Antes y después del uso de guantes.



¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Tener en cuenta: La palpación del punto de punción no debe realizarse después de la aplicación del antiséptico. De igual manera, los elementos de protección personal que se deben utilizar:

- Gorro
- Gafas de protección ocular
- Tapabocas quirúrgico
- Bata
- Guantes

Tener en cuenta: que los guantes no excluyen el procedimiento de lavado de manos.

5.3.6. SELECCIÓN DEL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO

Ver en consideraciones preliminares (Algoritmo de selección).

5.3.7. ASEPSIA DE LA PIEL: PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA LA INSERCIÓN DEL CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO.

La antisepsia cutánea es un paso importante en la prevención de infecciones relacionadas con los procedimientos de acceso vascular.

Recomendaciones Generales:

- Si el lugar previsto para la inserción de dispositivo de acceso vascular periférico, (DAVP) está visiblemente limpio, se puede aplicar la solución antiséptica, si está visiblemente sucio, se debe limpiar el sitio previsto con agua y con jabón antes de aplicar la solución antiséptica.
- Si hay exceso de vello en la zona elegida para implantar el catéter, no se debe afeitar la zona, ya que puede aumentar el riesgo de infección; se puede utilizar: tijeras de un solo uso o Clipper de cabeza desechable para no generar lesión durante el corte del vello y garantizar la integridad de la piel.
- Evaluar si el paciente presenta alergias o sensibilidad a los antisépticos cutáneos.
- Realizar la antisepsia de la piel, utilizando el agente antiséptico cutáneo de solución de clorhexidina en base alcohólica (gluconato de clorhexidina 0.5 y 2% y alcohol isopropílico al 70%), preferiblemente usar aplicador estéril de un solo uso, que contenga solución estéril, o sachet estériles; evitar productos de dosis múltiples.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

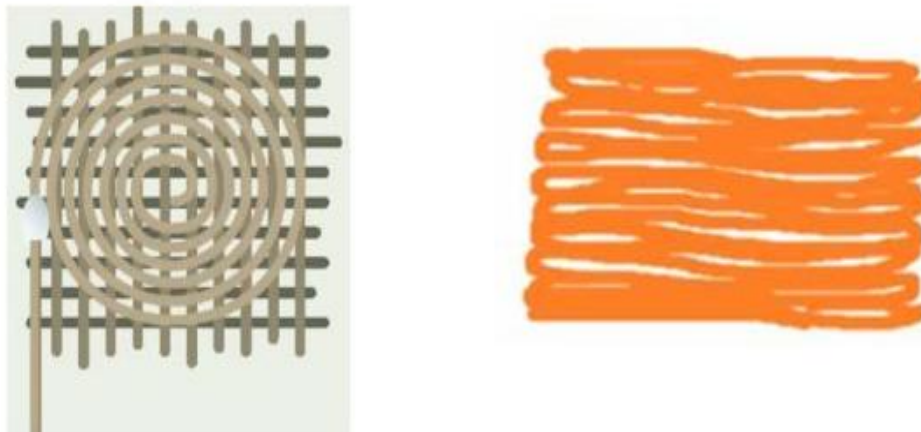
Utilizar la clorhexidina con precaución en neonatos prematuros o menores de 2 meses de edad debido a los riesgos de irritación de la piel y quemaduras químicas.

- Permitir que la solución antiséptica se seque naturalmente sin limpiar, ventilar o soplar sobre la piel (aprox. 30 segundos).
- No palpar la zona de inserción, después de la antisepsia.

Técnica de fricción:

Una fricción suave, con movimientos verticales y horizontales sobre el sitio de incisión o inserción, permite que la solución llegue mejor a las bacterias y las destruya, finaliza del centro a la periferia. Este método es el más eficaz.

Figura 1. Técnica Back and Forth o técnica de rejilla



Figuras 3 y 4: aplicar adelante y atrás, en bandas horizontales o verticales sin dejar espacios
(Fuente: <https://www.infeccionquirurgicazero.es/images/stories/recursos/presentaciones/2017/juan-f-navarro-resumen-5-medidas-de-IQZ.pdf>)

Un movimiento hacia adelante y hacia atrás durante 30 segundos garantiza que el sitio de inserción reciba suficiente antiséptico y la solución penetre las 5 primeras capas de células de la epidermis. Una vez que esto esté asegurado, finaliza del centro a la periferia.

5.3.8. APLICACIÓN DE COMPRESIÓN O TORNQUETE

El torniquete es usado para aumentar el llenado venoso; este se debe colocar aproximadamente de 7 a 10 centímetros encima del sitio de punción (4 dedos aproximadamente). El torniquete no debe estar tan ajustado porque puede obstruir el flujo

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNEiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

sanguíneo.

Dejar el torniquete por aproximadamente 30 – 60 segundos, no dejarlo por más de un minuto. No se debe golpear el sitio de punción, ya que puede generar traumatismos, hematoma y vasoconstricción. Para visualizar la vena aplique solución antiséptica.

Si aún no se ha podido visualizar o palpar la vena, se recomienda usar tecnología de visualización vascular para aumentar el éxito en los usuarios con acceso intravenoso difícil.

5.3.9. IMPLANTACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO (DAVP) CORTO

Una vez cuente con el equipo y material correcto y completo para el procedimiento:

- Preservar la intimidad del usuario, durante el procedimiento.
- Aconsejar sobre las posturas más convenientes que puede adoptar el usuario para su comodidad durante el procedimiento. En caso de usuarios pediátricos, adultos con alteración del estado de conciencia, presencia de delirium, etc., que puedan dificultar el procedimiento, solicitar colaboración por parte de los compañeros de trabajo, familiares o acudientes para inmovilizar la zona, y evitar traumatismos.
- Verificar nuevamente la identidad del usuario antes de realizar el procedimiento.
- Informar al usuario sobre el inicio del procedimiento.
- Traccionar la piel hacia abajo para fijar la vena con la mano no dominante.
- Introducir el catéter (según el calibre seleccionado) suavemente en el sitio seleccionado con el bisel hacia arriba en un ángulo aproximado de 15° a 30°.
- Se utiliza un catéter estéril nuevo para cada intento.
- Baje el catéter hasta que quede casi nivelada con la piel para evitar la perforación de la pared posterior de la vena y aváncela hasta obtener flujo sanguíneo.
- Aflojar o retirar el torniquete.
- Retirar suavemente el mandril e introducir simultáneamente el catéter. Hacer presión sobre el extremo distal del catéter para que no fluya la sangre, tomar muestras si es necesario.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- Pruebe permeabilidad de la vía introduciendo la SSN 0.9% de la jeringa prellenada. (Ver Recomendaciones irrigación del catéter: 12.1.4.9)
- Coloque conector libre de aguja (en lo posible de presión neutra que resista mínimo 100 activaciones y 32Lt hora).
- Deseche inmediatamente la aguja en un contenedor para objetos cortopunzantes (guardián). Y el resto de los elementos en cada recipiente correspondiente según el código de colores institucional.

5.3.10. IRRIGACIÓN DEL CATÉTER



Durante el lavado inicial aspire lentamente el dispositivo de acceso vascular periférico para obtener un retorno de sangre que fluya libremente y que tenga el color y la consistencia de la sangre completa; un componente importante para evaluar la función del catéter antes de la administración de medicamentos y soluciones.

Para irrigar el dispositivo de acceso vascular periférico, se utilizará el sistema de dosis única o jeringas prellenadas con SSN 0.9%, en caso de no contar con estos insumos, se utilizará una jeringa estéril x 10 cc y una bolsa de SSN 0.9% x 50 ml. Es de resaltar que, para permeabilizar el catéter en próximas oportunidades, (antes y después de la administración de cada dosis del medicamento) no se podrá reutilizar estos mismos insumos.

Los factores para tener en cuenta, al elegir el volumen del lavado, incluyen: el tipo y el tamaño del catéter, la edad del paciente y el tipo de terapia de infusión que se va a

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

administrar. Para el usuario adulto la irrigación del catéter deberá estar entre el rango: 5 – 10 ml y del paciente pediátrico entre 3 y 5 cc.

Para el lavado o irrigación del catéter, se debe usar una técnica de lavado pulsátil, esto significa la administración de 10 bolos cortos de SSN 0.9%, de 1 ml cada bolo, (adulto) hasta llegar a 10 ml, interrumpido por pausas breves; esta técnica es más eficaz para eliminar depósitos sólidos, fibrina, bacterias intraluminales en comparación con las técnicas continuas de bajo flujo.

5.3.11. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VENOSO PERIFÉRICO (DAVP)



Los dispositivos de acceso vascular periférico (DAVP) deberán estar fijados y asegurados para prevenir complicaciones asociadas con el movimiento en el sitio de inserción y pérdida involuntaria del acceso, disminuye la probabilidad de desarrollo de flebitis, infección, infiltración y desalojo o desplazamiento del catéter.

Los métodos utilizados para asegurar el DAVP no deben interferir con la capacidad de evaluar y monitorear rutinariamente el sitio del acceso venoso, tampoco debe impedir la circulación vascular o la administración de terapia endovenosa.

Los apósitos de aseguramiento del acceso vascular periférico corto debe tener un método de fijación integrado (dispositivo de aseguramiento integrado: ISD) que incluye una ventana semipermeable transparente (para visualización del sitio de inserción del catéter y piel circundante), y un borde de tela con tecnología de seguridad incorporada, barrera

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

bacteriana, viral y ambiental, adhesividad balanceada, transpirabilidad, facilidad de aplicación y de retiro.

Se debe elegir el método más apropiado para fijar el DAVP, en función de factores que incluyen: edad del paciente, turgencia e integridad de la piel, lesión anterior de la piel por adhesivo y cualquier tipo de drenaje del sitio de inserción.

En presencia de sangrado en el sitio de inserción, usar una gasa estéril, mientras la condición persista. Luego de esto, se debe cambiar a un apósito estéril, transparente y semipermeable tan pronto como sea posible y las condiciones del paciente lo requiera.

Si se presenta algún desplazamiento del DAVP, no se puede volver a avanzar el catéter.

Prácticas no recomendadas:

- Uso de cintas adhesivas no estériles, en el sitio de inserción.
- Uso de cintas adhesivas que no permiten visualizar el sitio de inserción del catéter.
- Uso cintas adhesivas con tensión.

5.3.12. ROTULACIÓN O MARCACIÓN

Terminada la fijación del dispositivo de acceso vascular periférico (DAVP), se procede a su rotulación, mediante una cinta, sticker o adhesivo de tela, con datos claros, legibles, sin tachones ni enmendaduras.

El registro debe contener:

- Calibre del catéter.
- # de canalización.
- Fecha del procedimiento.
- Hora del procedimiento (Horario militar).
- Servicio donde se realiza el procedimiento.
- Indicación (terapia intravenosa, tratamiento IV, nutrición parenteral periférica, transfusión o administración de medio de contraste).
- Responsable del procedimiento.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Calibre: 20	Canalización No: 1
Fecha: 02/03/2024	Hora: 14+30 H
Servicio: urgencias	
Indicación: terapia IV	
Responsable: Diana Sandoval	

Además, se procede a la marcación de todos los dispositivos médicos instalados al usuario, utilizando los sticker institucionales según corresponda:

- Equipo macrogoteo, equipo de bomba de infusión, extensión de anestesia, set transductor de presiones invasivas, equipos de transfusión, buretrol, etc.: Bandera/Sticker diligenciado de forma clara, legible, sin tachones ni enmendaduras, con los siguientes datos: (Fecha, nombres y apellidos completos, documento de identificación, medicamento o infusión y servicio donde se marcó el equipo).
- Conectores libres de aguja, llave de tres vías: se rotula con solo la fecha, por el tamaño del dispositivo que no permite registrar más datos.

		
NOMBRE:		
APELLIDO:	DOCUMENTO:	
NO. DE CAMA:	MEDICAMENTO:	
DOSIS:	FECHA:	HORA:
COD. 3053		AH-H-F-001AY V1-05-2019

	
NOMBRE:	
APELLIDO:	
DOCUMENTO:	
NO. DE CAMA:	FECHA:
COD. 3051	
AH-H-F-001AZ V1-05-2019	

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNEiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

 COD. 3052	CONTROL DE LÍQUIDOS	
	FECHA:	CAMA:
	NOMBRE:	
	SOLUCIONES:	
	MEZCLAS:	
	GOTEO:	HORA:
AH-H-F-001AJ V1-05-2019		

Posterior a la instalación de estos dispositivos, se procede a diligenciar y registrar todos los insumos en la historia clínica sistematizada.

5.3.13. OTRAS CONSIDERACIONES EN LA INSERCIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO (DAVP)

5.3.13.1. MANEJO DEL DOLOR EN LA INSERCIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO (DAVP)

Es importante tener en cuenta aplicar cualquier acción que favorezca la humanización en salud, implementando estrategias, para reducir el dolor asociado con la inserción de los dispositivos de acceso vascular. Esto va en función de la evaluación del estado del paciente, el nivel de desarrollo, edad y la participación de los usuarios y sus familias para determinar las preferencias y llevar a cabo con éxito el procedimiento.

Como primera medida, se deben emplear intervenciones para aumentar el éxito por primera vez en la inserción de estos dispositivos, por ejemplo: la visualización vascular previa, la planificación adecuada del sitio y del dispositivo de acceso vascular, personal entrenado y capacitado, actitud proactiva y amable del personal de enfermería, etc. es decir que se pueda garantizar una única punción con éxito.

Evaluar e identificar el dolor teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y edad del usuario:

- Infancia: el llanto, la expresión facial, la postura corporal, son indicativos de dolor.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- Los niños pequeños pueden tener comportamientos a valorar como: la expresión facial, el movimiento corporal y el llanto pueden ser indicativos de dolor.
- Los niños en edad preescolar y escolar pueden auto informar el dolor.
- Adultos: Se debe reconocer que algunos pacientes pueden tener miedo significativo a las agujas y que las estrategias de manejo de dolor pueden reducir el miedo.

Las estrategias de control de dolor, se basa en la distracción y esta se asocia con una reducción de la ansiedad y percepción del dolor. Es importante aplicar intervenciones conductuales como: distracción, relajación y ejercicios de respiración.

- bebés: Puede incluir; una combinación de técnicas que incluye envolver, amamantar, dar chupetes y mecerlos.
- Niños pequeños: soplar burbujas, lectura, canciones, o alguna actividad recreativa pasiva.
- Adultos: (ver televisión, escuchar música, conversar durante el procedimiento de una forma amable)

Es importante que en el manejo del dolor se revise el protocolo Manejo del dolor para procedimientos en pediatría en busca de atención humanizada que se encuentra en la ruta Guías/Internación/Pediatría/cuidado intermedio e intensivo pediátrico/Uci pediátrica/protocolo procedimientos sin dolor.

5.3.13.2. ESTABILIZACIÓN ARTICULAR

Los dispositivos de estabilización articular como una tabla, férula, o elemento rígido, se utilizan para facilitar la administración de infusiones, mantener la funcionalidad del dispositivo y minimizar las complicaciones de la terapia de infusión. Sin embargo, se debe limitar su uso por la restricción del movimiento de la parte del cuerpo estabilizada.

Cuando se coloca un dispositivo de acceso venoso periférico (DAVP), en algún punto de flexión de la extremidad, puede generar oclusión con el movimiento corporal. (Ej: fosa antecubital). Si tiene indicación, este dispositivo de estabilización articular debe ser acolchado y que apoye el área de flexión (Ej: mano, brazo, codo) para mantener una posición funcional; además, su colocación no debe impedir la inspección visual del sitio de inserción de acceso y la vía vascular.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

El dispositivo de estabilización articular, no debe ejercer presión, de tal manera que obstruya o haga constricción circulatoria, no debe generar lesiones por presión o daño a los nervios, debajo del dispositivo.

5.3.13.3. CONECTORES LIBRES DE AGUJA



Utilice un conector sin aguja conectado directa y firmemente al conector VAD, al conector hembra de un conjunto de extensión adjunto o a un lugar de inyección en un conjunto de administración para facilitar la infusión intermitente de soluciones y medicamentos.

El objetivo principal de los conectores sin agujas es eliminar el uso de agujas al conectar equipos de administración y/o jeringas al VAD o a los lugares de inyección y reducir las lesiones posteriores por pinchazo y la exposición a patógenos transmitidos por la sangre. **INS 1-5 (I).**

Se usan los conectores libres de aguja, con cierre “luer” para conectar jeringas y dispositivos de administración de medicamentos con el conector o salida del dispositivo de acceso vascular periférico, eliminando el uso de agujas.

En el puerto del dispositivo de acceso vascular periférico debe ir un conector libre de aguja. Se debe verificar que todas las conexiones Luer Lock estén seguras para evitar desconexiones y fugas accidentales en el sistema de infusión; es decir pérdida del sistema cerrado.

Todos los conectores sin aguja permiten cierto movimiento de líquido y reflujo sanguíneo al conectarse, desconectarse o ambas. **INS 8-12 (IV).**

El término neutral puede usarse para describir la función del conector sin aguja; No se recomienda una secuencia específica, pero se recomienda sujetar, ya que es inevitable cierto desplazamiento. Se recomienda utilizar la mejor secuencia de lavado y pinzamiento para minimizar el reflujo y los posibles

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

riesgos oclusivos o de infección asociados. **INS 2,9-16 (III).**

El mecanismo interno para el desplazamiento de fluido del conector sin aguja en uso en CVP Corto sugerido debe ser reconocido (p. ej., desplazamiento positivo o negativo o antirreflujo), para seguir instrucciones de uso del fabricante para lavar, sujetar y desconectar cuando se proporcionen.

Los nombres de las categorías de conectores sin agujas se derivan de la aplicación clínica de su funcionalidad; sin embargo, no existen criterios establecidos por parte de las agencias reguladoras de dispositivos que determinen qué dispositivo se asigna a cada categoría. **INS 2 (V).**

Desinfecte la superficie de conexión y los lados del conector sin aguja conectado a cualquier VAD para reducir la introducción de microbios intraluminales. Utilice desinfección activa o pasiva. Siga las instrucciones del fabricante para el uso tanto del conector sin aguja como del agente y/o producto desinfectante. Los factores principales que influyen en esta práctica incluyen el agente desinfectante, el tiempo requerido (es decir, aplicación y secado) y el método de aplicación.

1. Realice una desinfección activa mediante un frote mecánico vigoroso utilizando un hisopo plano que contenga alcohol isopropílico al 70 % o clorhexidina a base de alcohol adecuada para usar con dispositivos médicos. En ausencia de instrucciones del fabricante, considere el volumen de reflujo informado para cada tipo según lo registrado en los estudios publicados y use la siguiente secuencia. **INS 8-12: (IV).**

a. Desplazamiento negativo: enjuague, sujete, desconecte.

b. Desplazamiento positivo: enjuague, desconecte, sujete.

C. Antirreflujo: no se recomienda una secuencia específica, pero sí se recomienda el pinzamiento, ya que es inevitable cierto desplazamiento.

d. El término neutral puede usarse para describir la función del conector sin aguja; No se recomienda una secuencia específica, pero se recomienda sujetar, ya que es inevitable cierto desplazamiento.

El tiempo de secado con alcohol isopropílico al 70% es de 5 segundos; La clorhexidina a base de alcohol requiere 20 segundos. La povidona yodada requiere más de 6 minutos para secarse completamente, lo que la hace menos favorable para la práctica clínica. Los tiempos de secado en la práctica clínica dependen de la humedad y el clima del entorno asistencial. **INS 33 (IV).**

Un tiempo de secado adecuado del conector sin aguja después de la desinfección es esencial para reducir la carga microbiana y la posibilidad de entrada al torrente sanguíneo, reduciendo así las infecciones del torrente sanguíneo

El Uso de conector Nano clave que es conector libre de aguja usado en el entorno neonatal.

Las llaves de paso o llaves de 3 vías deben contener en cada uno de sus puertos, los conectores libres de aguja, en lugar que las tapas sólidas.

¡Corazón para Servir!

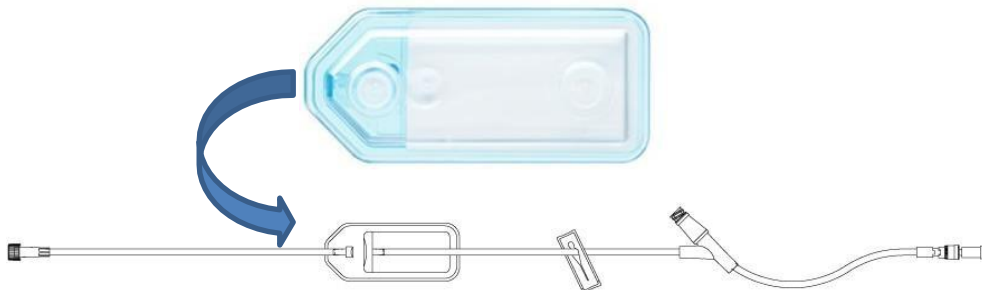
Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

5.3.13.4. USO DE FILTROS



El uso de filtros en los dispositivos de acceso vascular periférico reduce la aparición de flebitis en pacientes hospitalizados, elimina partículas inadvertidas (por aperturas de ampollas de vidrio que pueden causar trombogénesis, alteración de la microcirculación, y alteración de la respuesta inmunitaria), contaminación microbiana y reducción de microburbujas (< 1 mm de diámetro), de aire arrastrado en soluciones de infusión, favoreciendo la seguridad en la atención de salud. El filtro de 0.2 micras para las soluciones de nutrición parenteral sin emulsiones inyectables de lípidos se deben cambiar cada 24 horas. El filtro de 1.2 micras para soluciones de nutrición parenteral que contengan mezcla de nutrientes totales también se deben cambiar cada 24 horas el filtro. El filtro de emulsiones lipídicas se debe cambiar cada 12 horas.

5.3.13.5. EXTRACCIÓN O RETIRO DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO (DAVP)

La necesidad clínica de cada dispositivo de acceso vascular periférico se evalúa diariamente y en cada turno; estos son retirados cuando está clínicamente indicado Ej.: complicación no resuelta, interrupción de la terapia de infusión o cuando ya no es necesario para el plan de atención. Además, otras indicaciones para su retiro: cuando el usuario presenta signos de flebitis (calor, dolor, sensibilidad, eritema y cordón venoso palpable), mal funcionamiento del catéter, extravasación, reflujo a través del punto de inserción, signos de irritación local, sospecha de infección y/o trombosis venosa.

Inicialmente, se debe realizar el lavado de manos y se explica al paciente, familiar o acudiente, el procedimiento a realizar (actividad anteriormente descrita). Luego, continuar con la desconexión de todos los dispositivos de administración de medicamentos y aspirar el conector del catéter antes de retirarlo; ya que, en caso de extravasación, para eliminar el medicamento vesicante de la luz del catéter, y tanto como sea posible del tejido subcutáneo. Se debe despegar la película transparente estéril suavemente, la cánula de la vena y comprimir sobre el lugar de punción con gasa estéril seca durante aproximadamente 3 minutos, colocando una cinta adhesiva posteriormente. Este adhesivo no debe ocluir la vía venosa anterior, ya que se debe evaluar una posible flebitis post infusión. Es importante comprobar la integridad del catéter

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

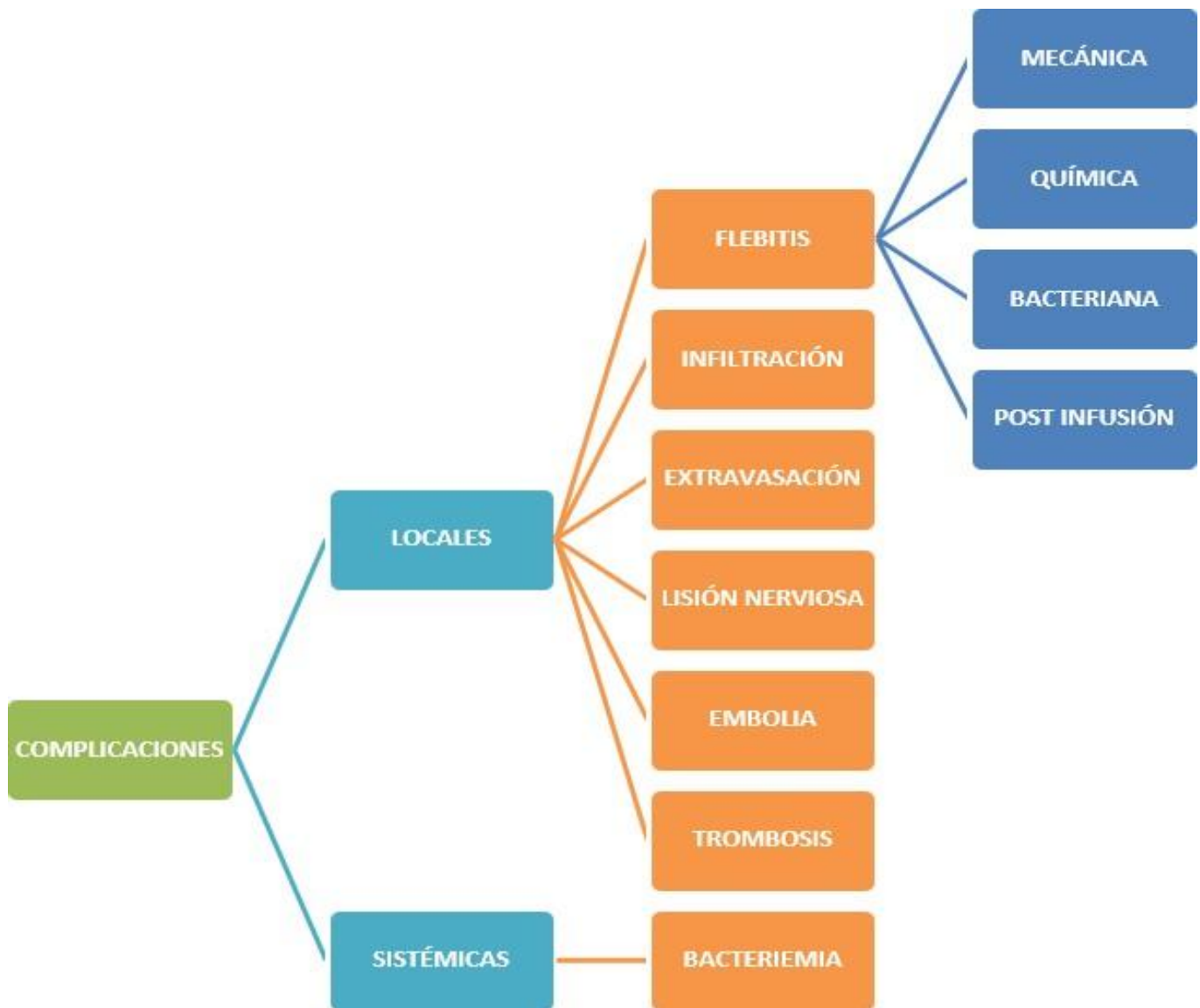
www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

tras su retirada y registrar la fecha y la hora y los hallazgos presentados en la historia clínica.

5.3.13.6. COMPLICACIONES



¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

5.3.13.6.1. COMPLICACIONES LOCALES

FLEBITIS

Es la presencia de Induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada y/o en el trayecto del catéter. Si hay presencia de flebitis hay que determinar la posible etiología: química, mecánica, infecciosa o post infusión.

Clasificación según su etiología:

- **Flebitis química:** La flebitis química puede estar relacionada con la administración de infusiones de medicamentos con aumento en la osmolaridad (>500 mOsm/L), PH <5 o > 9, medicamentos irritantes o vesicantes, solución antiséptica para la piel que no seca completamente y se introduce en la vena durante la inserción del catéter, etc. Se puede producir de manera inmediata.
- **Flebitis mecánica:** La flebitis mecánica puede estar relacionada debido a tres factores principales: ubicación en zonas de flexión corporales, inserción traumática de catéter de mayor calibre en una vena de menor longitud, inestabilidad de la fijación del catéter que provoca movimientos traumáticos en la vena. Su aparición se puede generar dentro de las 12 horas siguientes.
- **Flebitis infecciosa o bacteriana:** Es originada por cualquier tipo de microorganismo, por falta de una adecuada técnica aséptica en su inserción, y se puede evidenciar 72 horas después de su implantación.
- **Flebitis post infusión:** La flebitis post infusión, aunque no es muy común, ocurre después de la extracción del catéter durante las 48 a 96 horas siguientes. Puede estar relacionada con la inadecuada irrigación del catéter, previo a su extracción.

EXTRAVASACIÓN

Líquido vesicante en tejido subcutáneo ocasionando lesiones que pueden llevar a necrosis y dolor intenso.

INFILTRACIÓN

Líquido no vesicante en tejido subcutáneo con presencia de edema, piel fría y posible entumecimiento.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

LESIÓN NERVIOSA:

Esta lesión es definida como un dolor persistente, similar a una quemadura o parestesia en distribución específica por el nervio periférico, que empieza inmediatamente mientras la aguja está *in situ* o puede verse retrasada varias horas. En general, las evidencias históricas apuntan hacia un procedimiento traumático difícil (p. ej., varios intentos) o por formación de hematoma. El dispositivo de acceso vascular se retira inmediatamente cuando el paciente informa dolor de tipo parestesia durante la venopunción periférica y durante tiempo de permanencia del catéter.

EMBOLIA

La embolia aérea venosa es una complicación intraoperatoria infradiagnosticada ya que la mayor parte de los émbolos son de escasa significación clínica. En ocasiones supone una amenaza vital, es fundamental una rápida detección y tratamiento.

TROMBOSIS

Afección que surge en la que un coágulo de sangre en una vena provoca inflamación y dolor. La tromboflebitis suele ocurrir en las venas de la capa superior de la piel, ubicadas en áreas con flujo sanguíneo deficiente. En casos menos frecuentes, el coágulo puede ser el indicador de una afección más grave, llamada trombosis venosa profunda. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, inflamación y dolor.

5.3.13.6.2. SISTÉMICAS

Bacteriemia: Se define bacteriemia como la invasión del torrente circulatorio por microorganismos. Las bacteriemias se clasifican de acuerdo con el lugar de adquisición de la infección, el origen de la infección, el patrón clínico y el microorganismo aislado.

5.3.13.7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO (DAVP):

5.3.13.7.1. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Los dispositivos de inserción periférica se deben rotular correctamente con: calibre del catéter intravenoso corto, # de canalización, fecha del procedimiento, hora el procedimiento (horario militar), servicio donde se realiza el procedimiento, indicación (terapia intravenosa, tratamiento IV, nutrición parenteral periférica, transfusión o administración de medio de contraste) y el responsable del procedimiento. (datos que se deben consignados también en la nota del procedimiento).

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- Al manipular el catéter intravenoso periférico corto, aplicar la estrategia de higiene de manos, según los 5 momentos con la técnica de los 8 pasos (tiempo 20 a 30 seg.) después de haber aplicado la estrategia de higienización de manos 5 veces, debe realizar lavado de manos.
- Procurar el mantenimiento del sistema cerrado: Evite desconectar los equipos de administración de terapia IV con el Dispositivo de Acceso Venoso Periférico (DAVP) o del sitio de acceso. Tener en cuenta que en caso de desconexión, se debe garantizar desinfección pasiva.
- Si la terapia del usuario indica tener más de un dispositivo estos deben identificarse con # 1 o # 2 según el orden de la canalización; igualmente la nueva rotulación de los equipos tendrá un espacio donde debe ser consignado el número a la canalización que corresponda. (el numero registrado en el equipo debe coincidir con el número de la canalización).
- No deben existir llaves de tres vías conectadas sin ser utilizadas, en lo posible se debe retirar, esto debido a que entre más puerto tenga el usuario, se presenta más riesgo de infección.
- Al tener indicación de transfusión sanguínea se debe realizar venopunción exclusiva para el procedimiento, no podrá ser utilizado para ninguna otra terapia, debe ser retirada al cumplir 24 horas.
- Al tener indicación de administración de medio de contraste intravenoso, se debe realizar canalización exclusiva en el antebrazo, posterior a la realización del procedimiento el acceso venoso debe ser irrigado con 10 ml de SSN 0,9% utilizando jeringa prellenada y posteriormente debe ser retirado, esto debido a que los catéteres utilizados son de mayor calibre, ocupando en un gran espacio la luz del vaso sanguíneo, favoreciendo la aparición de flebitis. Cabe resaltar que, si se requiere continuar con este acceso venoso por difícil acceso, se recomienda verificar su permeabilidad, irrigar el dispositivo y valorar signos de flebitis de forma estricta a través de la escala Maddox.
- Si por alguna razón (infiltración, desplazamiento voluntario producido por el usuario sin contaminación del equipo, flebitis química o mecánica) el usuario ha requerido realizar el procedimiento de canalización más de una vez en las 24 horas, los equipos y demás dispositivos podrán mantenerse hasta cumplir las 96 horas excepto el conector que se cambia con cada canalización; (se ha ocurrido 24 horas posterior al acceso se deben cambiar los equipos).
- Realice el uso de un nuevo equipo de administración cuando inicie una nueva concentración de un medicamento intravenoso continuo para evitar la infusión de cualquier concentración anterior que quede en el dispositivo medico (equipos de infusión) a la velocidad prevista para la nueva concentración.
- Cambie los dispositivos médicos (equipo de infusión) para administración de nutriciones parenterales con o sin lípidos cada 24 horas.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- Cambie los dispositivos médicos (equipo de infusión) para administración de hemoderivados con cada dos unidades administradas (criterio sujeto a cambio por ficha técnica de fabricante del dispositivo adquirido por la institución).
- No se realizará más de dos punciones fallidas por cada auxiliar de enfermería (solo dos auxiliares podrán intentar dos punciones cada una) para la inserción del DAVO corto, posterior a ser evaluado el capital venoso del paciente.

5.3.13.7.2. DESINFECCIÓN DE PUERTOS Y CONECTORES

Se debe evaluar la permeabilidad de los dispositivos de acceso vascular (DAV) (es decir, lavarlos) antes de cada infusión para evaluar la función del catéter y prevenir complicaciones. **11 (III). Estándar 38.1 INS 2024.**

Los VAD se lavan después de cada administración de medicamento con un volumen suficiente y una velocidad adecuada para completar la administración del medicamento y reducir el riesgo de contacto entre medicamentos incompatibles. **Estándar 32.2, INS 2024.**

Desinfectar las superficies de conexión (es decir, conectores sin aguja) antes de los procedimientos de lavado. **Estándar 32.3, INS 2024.**

Realizar higiene de manos antes de cualquier manipulación, utilizar guantes y los EPP.

Los equipos de terapia IV, deben estar conectados al dispositivo de acceso venoso periférico, si el usuario requiere movilización, traslado y desconexión de este circuito, la parte distal del equipo de terapia IV, se va a proteger con el tapón que venía de fábrica, es por lo que el tapón no se debe desechar cuando se abren los equipos, de lo contrario, sujetarlo del mismo equipo con una cinta adhesiva, cercano a la cámara de goteo.

Es obligatorio realizar la desinfección activa de los puertos o de las válvulas de inyección, con desinfectante de un solo uso (sachet de alcohol isopropílico al 70%), realizando fricción en el puerto con esta almohadilla, y con una duración aproximada de 15 a 20 segundos cada vez que se conecte los dispositivos de terapia IV (jeringas para irrigar el catéter o administrar medicamentos, equipo macro goteo, equipo de bomba de infusión, etc.).

La recomendación en estos casos es el uso de desinfección pasiva, a través de unos tapones desinfectantes de un solo uso, estos contienen un agente desinfectante para crear una barrera física a la contaminación entre usos. Si no se cuenta con este insumo, la desinfección activa es de obligatorio cumplimiento.

Es importante resaltar, que el personal asistencial deberá reducir al mínimo imprescindible la manipulación de conexiones.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNEiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

5.3.13.7.3. REGISTRO EN HISTORIA CLÍNICA

Notas de enfermería:

Durante el recibo y entrega de turno en ronda, se verifica el adecuado control y manejo del dispositivo de acceso vascular (DAVP), para luego registrar en la historia clínica sistematizada la nota de enfermería, desde el aplicativo Índigo Crystal (ruta: Módulo Hcl/ registrar/ estado de paciente/ Notas de enfermería).

Las notas de enfermería como registros clínicos de valoración, evolución y seguimiento de los pacientes, deben contener una información clara, precisa y completa, que permita verificar el trabajo que realiza el personal de enfermería, sus actividades, etc.

Las notas de enfermería, en relación a los dispositivos de acceso vascular periférico son:

- **Nota de enfermería de ingreso:** Registrar según modelo SOAP, la nota de enfermería, anotando: tipo de acceso venoso, ubicación, calibre del dispositivo, fecha y hora de colocación, servicio que instauró el dispositivo (si es extrahospitalario es obligatorio hacer cambio del dispositivo de acceso vascular periférico), condiciones del catéter, medicamentos administrados (si es irritante o vesicante), valoración de la escala Maddox, hallazgos presentados, etc.
- **Nota de enfermería de recibo y entrega:** Registrar tipo de acceso venoso, ubicación, calibre del dispositivo, fecha y hora de colocación, servicio que instauró el dispositivo, condiciones del catéter y de la piel, medicamentos administrados (si es irritante o vesicante), valoración de la escala Maddox, etc.
- **Nota de enfermería cambio de dispositivo de acceso venoso periférico:** Registrar el motivo del cambio de la canalización (este debe coincidir con la hoja de venopunción), registrar la ubicación del dispositivo que se ha retirado, y colocar el nuevo acceso venoso, ubicación, calibre del dispositivo, fecha y hora de colocación, servicio que instauró el dispositivo, condiciones del catéter, medicamentos administrados (si es irritante o vesicante), valoración de la escala Maddox, etc.
- **Nota de enfermería de seguimiento de la venopunción:** Si pasadas las 72 horas de la instalación del dispositivo de acceso vascular periférico, no se ha realizado el cambio por alguna causa justificada, (difícil acceso venoso), se debe realizar la nota de enfermería explicando el no cambio de este dispositivo; además del mantenimiento o curación realizada en dicho acceso venoso.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- **Nota de enfermería de seguimiento a sitios de punción previos:** Realizar seguimiento, al menos 24 horas después del retiro del dispositivo de acceso vascular periférico (DAVP) esto con el fin de valorar flebitis post infusión, prevenir evolución de las flebitis, e identificar oportunamente cualquier complicación.

5.3.13.7.4. ESCALA MADDUX

ESCALA VISUAL DE VALORACIÓN DE FLEBITIS MADDUX			
PUNTAJE	SIGNOS Y SÍNTOMAS	VALORACIÓN DE ESCALA	ACTIVIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA
0	Sin dolor, eritema, hinchazón, ni cordón palpable en la zona de punción.	No signos de flebitis.	Observar punto de inserción.
1	Zona de punción dolorosa, sin eritema, hinchazón ni cordón palpable en la zona de punción.	Posibles signos de flebitis.	Observar punto de inserción.
2	Zona de punción dolorosa, con eritema y/o hinchazón, sin cordón palpable en la zona de punción.	Inicio de flebitis.	Retiro del catéter
3	Zona de punción dolorosa, con eritema, hinchazón, endurecimiento o cordón venoso palpable > 6 cm por encima del sitio de inserción.	Etapa media de flebitis.	Retire el catéter y valore el tratamiento.
4	Zona de punción sensible con eritema, hinchazón, endurecimiento, cordón venoso palpable > 6 cm por encima del sitio de inserción y/o purulencia.	Avanzado estado de flebitis.	Retire el catéter y valore el tratamiento.
5	Trombosis venosa franca con todos los signos anteriores y dificultad o detención de la perfusión.	Tromboflebitis	Retire el catéter e inicie el tratamiento.

La escala Maddox es un parámetro orientador para la identificación de la flebitis, pues clasifica la severidad de la flebitis de acuerdo con el número de señales presentes y su intensidad y extensión.

Es importante usar una escala que sea válida, confiable y clínicamente factible; se debe aplicar conscientemente mediante un método de evaluación permanente. Actualmente en la institución se aplica una Escala de valoración de Flebitis denominada: MADDUX.

Se debe registrar en las notas de enfermería, todos los datos obtenidos de la valoración de la escala, y en base a sus resultados, tomar decisiones (seguimiento estricto, retiro del catéter, etc.) en pro de la seguridad de paciente, y una atención de calidad.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

Si el usuario presenta cualquier complicación o flebitis, el personal de enfermería deberá informarle al médico de turno para el seguimiento multidisciplinario, además de realizar el reporte de este suceso de seguridad, a través de los diferentes canales institucionales (formato y/o reporte, e-mail, llamadas, mensajes, etc.)

5.3.13.7.5. APLICATIVO HOJA DE VENOPUNCIÓN

Se debe diligenciar: La hoja de venopunción sistematizada, en la siguiente ruta: Índigo Crystal / módulo Historia clínica/ registrar/ registro de actividades/, Hoja de venopunción.

De forma completa y verídica, que los datos puedan coincidir con las notas de enfermería; se debe hacer uso de la gráfica existente (sitio de acceso venoso).

5.3.13.7.6. HOJA DE MAPEO

Si se requiere el traslado de un usuario, de un servicio a otro, se deberá diligenciar el formato de mapeo, y allí registrar gráficamente el sitio de la venopunción, consignando allí también, la información sobre la inserción: fecha, hora, servicio, calibre, etc.

5.3.13.8. CAMBIO DE DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO:

Realice cambio del catéter, de los equipos y dispositivos médicos (llaves de tres vías, conectores libres de aguja, extensiones bifurcadas, equipo macrogoteo, equipo de bomba de infusión al cumplir las 96 horas de su inserción teniendo en cuenta la hora de canalización. (ningún servicio podrá establecer un turno específico para realizar todas las inserciones de DAVP corto que cumplen con el tiempo establecido por protocolo institucional).

Recuerde que los usuarios remitidos de otra institución se les debe realizar por protocolo descolonización (baño general con jabón Clorhexidina) y posteriormente se realiza el cambio del dispositivo de acceso vascular periférico (DAVP) corto y cambio de dispositivos médicos requeridos para la terapia de infusión así estén dentro de las primeras 24h (el acceso venoso periférico extrahospitalario debe ser registrado en la nota de enfermería con su respectiva valoración de escala Maddox).

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

PERMEABILIDAD DE LOS CATÉTERES:

- Se debe lavar el catéter antes de usar para comprobar su correcto funcionamiento con jeringa precargada de SSN 0,9% con barril de 10 ml, con técnica pulsátil; En caso de no contar con estos insumos, se utilizará una jeringa estéril x 10 cc y una bolsa de SSN 0.9% x 50 ml.
- Si el paciente tiene terapia intermitente o el acceso no se va a usar por un espacio prolongado de tiempo, lavar el catéter periódicamente, con jeringa precargada de SSN 0,9% con barril de 10 ml, con técnica pulsátil cada 8 horas, lo cual se debe incluir en la tarjeta de medicamentos (para conocimiento del auxiliar de enfermería a cargo del usuario) y el Kardex del paciente (para conocimiento de la Enfermera jefe de turno) verificando el cumplimiento de este cuidado de enfermería para el mantenimiento del DAVP corto.

Es esencial mantener la permeabilidad del catéter, su oclusión constituye una causa frecuente de complicaciones no infecciosas; puede definirse como la incapacidad para infundir o aspirar sangre a través del catéter y cuyo origen puede encontrarse en el cúmulo de fibrina o un trombo en el lumen del catéter o la vena, medicación precipitada en el lumen u otros factores externos; Es indispensable la correcta colocación del DAVP corto para asegurar la terapia intravenosa que el paciente necesita así como prevenir infiltraciones y extravasaciones. Es necesario reducir el alto grado de variabilidad existente en la práctica de mantener la permeabilidad de los catéteres venosos periféricos.

En el mantenimiento del dispositivo del acceso vascular (DAVP), La irrigación o permeabilización se realiza:

- Para asegurar la limpieza del catéter.
- Para evitar incompatibilidad entre medicamentos.
- Para minimizar riesgo de flebitis química.
- Para minimizar el riesgo de flebitis post infusión.
- Antes/después de extracción o transfusión / Para prevenir la formación de trombos.

6. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO

Para evaluar el procedimiento de venopunción la institución tiene implementada una lista de chequeo estandarizada, para realizar seguimiento y adherencia al protocolo de accesos venosos periféricos, el cual se debe diligenciar cada vez que se realice seguimiento de adherencia al protocolo establecido.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

7. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AL USUARIO, FAMILIA O CUIDADOR EN MANTENIMIENTO DE LOS CATÉTERES

- Fomentar el lavado de manos y las buenas prácticas de higiene corporal.
- Educar al paciente en el cuidado que debe tener con los accesos venosos y no manipulación de los conectores libres de aguja, llaves de tres vías o cualquier equipo de terapia IV.
- Educar al paciente sobre signos de alarma en caso de presentar flebitis.
- No realizar movimientos fuertes en zona donde está instalado el DAVP, porque es importante cuidar el no desplazamiento.

Esta información esta consignada en la infografía de Cuidados del usuario y familia en acceso vascular periférico, anteriormente descrita.

8. CONCLUSIONES

Es importante aplicar todas las medidas adecuadas en el manejo de los dispositivos de accesos vasculares periféricos, ejecutando las actividades con calidad y seguridad en nuestros usuarios; por lo que la institución ha realizado un compendio básico de actividades para que el personal de enfermería aplique de forma obligatoria, denominada:

9. ESTRATEGIA MULTIMODAL: FLEBITIS ZERO

Es un conjunto de acciones, que permiten la mitigación de complicaciones y disminución en la aparición de flebitis. En esta estrategia se agrupan actividades prioritarias que debe tener en cuenta el personal de enfermería y que es de fácil revisión y aplicación.

Las actividades principales a tener en cuenta son:

- ✓ Elección Adecuada del tipo del catéter.
- ✓ Higiene adecuada de Manos.
- ✓ Uso de medidas de barrera total durante la inserción.
- ✓ Uso de Clorhexidina Alcohólica en la preparación de la piel.
- ✓ Limitar el número de intentos de inserción.
- ✓ Estabilización del catéter con película transparente estéril.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

- ✓ Uso de conectores libres de aguja.
- ✓ Mantenimiento aséptico del catéter.
- ✓ Retiro de catéteres innecesarios.

Anexo 2: estrategia multimodal: Flebitis Zero.



Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado



ESTRATEGIA MULTIMODAL FLEBITIS ZERO



MEDIDA	ACTIVIDAD
ELECCIÓN ADECUADA DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO.	- Verificar las características del paciente: comorbilidades (fístula A-V, mastectomía, lesiones, etc.) confort (diestro o zurdo, parestias), edad. - Tener en cuenta el Score DIVA para población neonatal y pediátrica. - Aplicar el algoritmo de selección del acceso vascular, teniendo en cuenta las variables: PH, osmolaridad del medicamento y tiempo de duración de la terapia endovenosa.
HIGIENE ADECUADA DE MANOS	Antes y después de realizar la inserción del catéter intravenoso periférico, es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, (gluconato de clorhexidina) aplicando los 11 pasos, con una duración de lavado entre 40-60 segundos.
USO DE ELEMENTOS DE BARRERA (EPP)	El uso de los elementos de protección personal (EPP), es de obligatorio cumplimiento. Tener en cuenta que los guantes no excluyen el procedimiento de lavado de manos.
USO DE CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL	Realizar la antisepsia cutánea con clorhexidina en base alcohólica 0,5% - 2%, aplicarla bajo la técnica de rejilla.
LIMITAR EL NÚMERO DE INTENTOS DE INSERCIÓN	Entre más punciones, mayor el riesgo de incidencia de complicaciones: infecciones, trombosis, etc.
ESTABILIZACIÓN DEL CATÉTER CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL.	Los dispositivos de acceso vascular periférico (DAVP) deberán estar fijados y asegurados para prevenir complicaciones asociadas con el movimiento en el sitio de inserción y pérdida involuntaria del acceso, disminuye la probabilidad de desarrollo de flebitis, infección, infiltración y desalojo o desplazamiento del catéter. Los apósitos deben ser transparente semipermeable y estériles.
USO DE CONECTORES LIBRES DE AGUJA	Se usan para conectar jeringas y dispositivos de administración de medicamentos con el conector o salida del dispositivo de acceso vascular periférico, eliminando el uso de agujas, reduciendo los accidentes biológicos y la exposición a microorganismos que favorecen las infecciones. Se debe verificar que todas las conexiones Luer Lock estén seguras para evitar desconexiones y fugas accidentales en el sistema de infusión; es decir pérdida del sistema cerrado.
MANTENIMIENTO ASÉPTICO DEL CATÉTER.	- Uso de clorhexidina en el cuidado del punto de inserción. - Uso de apósito estéril preferente transparente semipermeable. - Vigilar y registrar en cada turno el estado del punto de inserción. - Mantener la permeabilidad del catéter mediante lavado periódico de los mismos, con SSN 0,9%. - Para la desinfección de puertos y conectores, la obligatoriedad, de realizar la desinfección activa de los puertos con sachet de alcohol isopropílico al 70%, realizando fricción en el puerto, durante 12 segundos. - Realice cambio del catéter y de sus equipos (llaves de tres vías, conectores libres de aguja, extensiones de anestesia, equipo macro - micro goteo, equipo de bomba de infusión, buretotes, etc.) a las 72 horas de su inserción, siempre y cuando este sea posible; de lo contrario se debe realizar curación o mantenimiento. - Siempre que se cambie un catéter, se cambiarán también todos los equipos de perfusión. - Cuando se tenga un dispositivo de acceso vascular extrahospitalario, se les debe retirar ese acceso venoso y todos sus equipos de infusión IV, realizar nuevamente el procedimiento de inserción del catéter. - Procurar el mantenimiento del sistema cerrado: Evite desconectar los equipos de administración de terapia IV con el DAVP o del sitio de acceso. Tener en cuenta que, si se presenta alguna desconexión no programada, del circuito, se debe realizar cambio en los equipos.
RETIRO DE CATÉTERES INNECESARIOS	Retirar rápidamente cualquier catéter intravascular que no sea imprescindible. - Quitar el catéter venoso periférico si el paciente presenta signos de flebitis, por mal funcionamiento del catéter, extravasación, reflujo a través del punto de inserción, signos de irritación local, sospecha de infección y/o trombosis venosa.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

10. RESPONSABLES

- Profesionales de Enfermería
- Auxiliares de Enfermería

11. BIBLIOGRAFÍA

1. Estándares de terapia de infusión Intravenosa INS, 8° edición. 2021 Lisa Gorski, MS, RN, HHCNS-BC, CRNI®, FAAN Lisa A. Gorski, MS, RN, HHCNS-BC, CRNI®, FAAN Lynn Hadaway Lynn Hadaway, MEd, RN, NPD-BC
2. Revista Chilena de Anestesia Vol. 50 Núm. 5 pp. 685-689/2021, Difficult venous access in pediatrics
3. <https://flebitiszero.com/app/formacion/formacionPdf.html>
4. Pérez Melgarejo H. Flebitis post infusión en catéteres venosos periféricos: una actualización del arte. Horiz Enfermería, 22, 2, 37-48. 2011.
5. Kelli Rosenthal, RN,BC, ANP, APRN,BC, CRNI, MS. Cuando aparece la flebitis. Nursing. 2007, Abril 47McCaffrey Boyle D. & Engelking C. Vesicant extravasation: Myths and Realities, ONF, Vol. 22, No 1, 1995 pages 57-68.
6. Myths and Realities, ONF, Vol. 22, No 1, 1995 pages 57-68.
7. JOHNSON Y JOHNSON. Medical. Departamento de servicios educacionales. Terapia intravenosa, Págs. 3 – 31.
8. Prevención de heridas por pinchazo de aguja en unidades de cuidados de la salud (ALERT: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings). Noviembre 1999.DHHS (NIOSH) Publicación No. 2000-108.
9. Brown JD, Moss HA, Elliot TSJ. El potencial de contaminación microbiana en catéter desde un conector sin aguja (The Potential for Catheter Microbial Contamination from a Needleless Connector). The Hospital Infection Society; 181-189; 1997.Challenge organism: Staphylococcus epidermidis.
10. SILVEIRA AI, RIAL B, GARCÍA MP, REQUEIJO FJ, BONOMA A. *Complicaciones de la terapia intravenosa como causa de prolongación hospitalaria*. Enferm Científica 1992; 118: 20-21.
11. GANTZ NM, PRESSWOD GM, GOLDBERG R, DOERN G. *Effects of dressin type and change interval on intravenous therapy complication rates*. Diagn Microbiol Infect Dis 1984; 2: 325-332.
12. *Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España (EPINE); Informes de Aragón: años 2005 y 2006*. Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.
13. GARITAZO TELLERÍA, B, BARBERENA IRIARTE C, ALONSO VALLEJO M Y GISTAU TORRES C. *Revisión sistemática: efectividad de los cuidados en el mantenimiento de catéteres de inserción periférica*. Enfermería Clínica 2002; 12 (4): 164-172.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNEiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD	FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2025
	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: GIC-PT-ENF-001
		PAGINA: 1 de 42

14. BELLIDO VALLEJO JC, CARRASCOSA GARCÍA MI, GARCÍA FERNÁNDEZ FP, TORTOSA RUIZ MP, MATEOS SALIDO MJ, DEL MORAL JIMÉNEZ J, PORTELLANO MORENO A, MARTÍNEZ MARTOS RM, CASTILLO DORADO B, CABRERA CASTRO MC, OJEDA GARCÍA M, COLMENERO GUTIÉRREZ MD, JESÚS UCEDA T. *Guía de cuidados en accesos venosos periféricos y centrales de inserción periférica*. Evidentia 2006; 3 (9) [ISSN: 1697-638X]. <http://www.index-f.com/evidentia/n9/guia-avp.pdf>.
- 15.. BEST PRACTICE «*Manejo de los dispositivos intravasculares periféricos*». 2008; 12 (5): 1-4. Acceso: http://www.isciii.es/htdocs/redes/investen/Best_Practice.htm
16. Revision de Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 2002 C.D.C.-USA en su Versión Española adaptada 2006.
17. Álvarez, F. J. Y., de la Rosa Fernández, P. A., Martínez-Polo, A., Arozarena, E. D., Senar, J. B. S., Etxarri, N. G., & Villanueva, A. M. (2016). Incidencia de Flebitis asociada a Catéteres Centrales de Inserción Periférica en UCI Adultos: Implementación de un Protocolo para Enfermería. *Enfermería Global*, 16(1), 416-437.
18. Sánchez, M. D. R. C., Matez, S. G., & Cueto, M. D. C. H. (2016). CA 2-111: VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS. *ENFERMERÍA DOCENTE*, 1(106), 43.
19. Lisa Gorski, MS, RN, HHCNS-BC, CRNI®, FAAN Lynn Hadaway, Ed, RN-BC, CRNI Mary E. Hagle, PhD, RN-BC, FAAN Mary McGoldrick, MS, RN, CRNI Marsha Orr, MS, RN Darcy Doellman, MSN, RN, CRNI®, VA-BC. *Infusion Therapy Standards of practice*. 2016.

12. ELABORO, REVISO Y APROBÓ

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Departamento de Enfermería	NOMBRE: Nelson Leonardo Fierro González Hugo Segura Puello	NOMBRE: Juan Diego Fierro Oliveros
CARGO: Jefe de los servicios Departamento de Enfermería	CARGO: Subgerente Técnico Científica Coordinador Educación Médica	CARGO: Gerente
FECHA: Diciembre 2024	FECHA: Febrero 2025	FECHA: Febrero 2025

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia